Kit do entrevistador

PlantãoSeguro · Etapa 3 · versão de 03/11/2026 · entrevistas até 06/11, para entrar na entrega de 07/11

> **O que precisamos de você:** 2 conversas curtas, com um coordenador de escala ou um médico plantonista, e os números anotados na ficha. Leve também a folha de casos para os coordenadores. Nada de nome, hospital ou paciente.

1. Por que isso importa

O feedback da Etapa 2 apontou que, sem dados reais, não conseguimos demonstrar que os padrões do trabalho representam hospitais e médicos reais. As entrevistas são a parte mais barata de responder a isso, e uma resposta muda o resultado inteiro. Na simulação, o ganho de tempo depende de como o coordenador real já trabalha:

Se o coordenador real...	Ofertas por vaga hoje	Tempo que o modelo economiza
Chama sem conferir a agenda (premissa atual)	3,31	57%
Já chama só quem pode ir, em qualquer ordem	1,82	27%
Já escolhe tão bem quanto nossa regra simples (baseline)	1,41	7%

Simulação com dados sintéticos, nas 392 vagas do período de teste. Não é evidência de hospital real.

A pergunta que decide é: quantos médicos você chama até alguém aceitar? Se só der tempo de uma, faça essa. Não conte estes números a quem for entrevistar, para não influenciar a resposta.

2. Quem entrevistar

- **Quantos:** 3 a 5 coordenadores de escala e 3 a 5 plantonistas, como a Entrega 1 prometeu. Cada integrante tenta 2 conversas e avisa no grupo, para ninguém procurar a mesma pessoa.
- **Perfil ideal:** pronto-socorro de hospital privado, noite ou fim de semana, clínica médica ou pediatria. Quem está perto disso também vale; anote o que for diferente.
- **Duração:** 25 a 40 min com coordenador, 15 a 25 min com plantonista. Pode ser por vídeo ou telefone.

Convite (adapte à vontade):

> Oi, [nome]. Faço pós em IA aplicada a negócios no Mackenzie e, no trabalho final, meu grupo estuda como preencher vagas de plantão com menos ligações e mais transparência. Posso te fazer algumas perguntas por 30 minutos esta semana? É voluntário, não gravo e não anoto nome, hospital nem nada que identifique você. Só preciso de ordens de grandeza, sem abrir nenhum dado do hospital.

3. Regras

1. **Voluntário e com o termo lido.** Leia o termo da seção 4 antes da primeira pergunta. A pessoa pode pular perguntas ou parar quando quiser.
2. **Nunca anote** nome, hospital, CRM, telefone, paciente ou caso individual. Se a pessoa citar, deixe fora da ficha. Aqui entram só ordens de grandeza, nunca registros individuais.
3. **Use códigos:** C1, C2... para coordenadores e P1, P2... para plantonistas. Combine no grupo quem usa qual código.
4. **Sem gravação.** As fichas ficam fora do Git, em pasta privada do grupo. Ao repositório público só vão números agregados e frases sem identificação.
5. **Peça número ou faixa** ("entre 3 e 5"). "Não sei" é resposta válida: nunca chute no lugar da pessoa.
6. **Pergunte antes de mostrar.** Faça os blocos de números antes de explicar o produto ou mostrar telas, para não induzir.
7. **Não abra o gabarito** da revisão às cegas. Quem entrevista também não pode saber de onde vem cada lista.

> **Ética em pesquisa: a confirmar com o professor antes da primeira entrevista.** A Res. CNS 510/2016 (art. 1º, parágrafo único) dispensa do sistema CEP/Conep a atividade exclusivamente de ensino, sem finalidade de pesquisa científica, de profissionais em especialização. A mesma norma tira dessa dispensa TCC, monografias e similares (§ 1º) e exige submissão se o resultado for aproveitado em projeto de pesquisa (§ 2º). O Ofício Circular 17/2022 da Conep lembra que a instituição pode ter análise própria. Tratamos estas conversas como validação de mercado dentro de uma disciplina, mas essa classificação não cabe ao grupo: quem confirma é o Prof. Fabio, com o Mackenzie. Fontes lidas em 03/11/2026; validar com jurídico. Se o trabalho virar artigo ou TCC, a conversa com o comitê de ética vem antes.

4. Termo (leia em voz alta)

> Esta conversa faz parte de um trabalho da disciplina Hands On: Aplicação de IA nos Negócios, da pós-graduação do Mackenzie. Queremos entender como as vagas de plantão são preenchidas hoje. É um levantamento para o trabalho, não uma consulta médica ou jurídica. Participar é voluntário e não há pagamento nem vínculo com hospital ou empresa. Você pode pular qualquer pergunta ou parar quando quiser, sem explicar. Não vou gravar nem anotar seu nome, o hospital, CRM, telefone ou informação de paciente; por favor, não cite nomes. Só números agregados e frases sem identificação podem aparecer no repositório público do trabalho e na apresentação em sala. Se mudar de ideia até 06/11, me avise e suas respostas saem da análise. Posso seguir?

Anote "consentimento: sim" na ficha. Se a resposta for não, agradeça e encerre.

5. Roteiro do coordenador de escala (25 a 40 min)

Se o tempo apertar, faça só os blocos B e D.

A. Contexto (2 min)

Nº	Pergunta
1	Que serviço você coordena (pronto-socorro, UTI, enfermaria)? O hospital é privado ou público?
2	Quantos médicos há na sua lista para chamar? De quais especialidades?

B. Como é hoje, em números (10 min)

Nº	Pergunta
3	Por mês, quantas vagas surgem fora da escala fixa (falta, troca, atestado)?
4	Dessas, quantas ficam sem ninguém ou só fecham na última hora?
5	**Quando surge uma vaga, quantos médicos você chama até alguém aceitar?** Num caso típico e num caso ruim. (a mais importante)
6	Quanto tempo passa entre saber da vaga e ter o médico confirmado? Típico e pior caso.
7	Por qual canal você chama (WhatsApp, telefone, grupo, sistema)? Quanto espera a resposta antes de chamar o próximo? Depois de quantas tentativas você escala o problema?
8	O que você confere antes de chamar? Deixe a pessoa responder e só depois pergunte o que faltou: CRM, especialidade, agenda do médico, distância, descanso desde o último plantão.
9	Como decide quem chamar primeiro? De cada 10 chamados, quantos vão para os mesmos poucos médicos?
10	De cada 10 médicos que aceitam, quantos faltam ou cancelam em cima da hora?
11	Com quanta antecedência as vagas costumam surgir? De cada 10, quantas com 24 horas ou mais?
12	Quantas horas por semana você gasta preenchendo vagas?

C. Custo e valor (5 min)

Nº	Pergunta
13	O que acontece quando uma vaga fica descoberta (fecha leito, paga mais, colega dobra)? Qual é o custo, em ordem de grandeza?
14	Vocês usam empresa ou cooperativa para escalar? Quanto custa, por plantão ou por taxa?
15	Quem decidiria comprar uma ferramenta assim? Em que faixa por mês faria sentido?
16	**Depois de 6 meses usando uma ferramenta dessas, o que faria você dizer que deu certo?** Peça um número.

D. Revisão às cegas (10 min)

Abra a folha de casos e leia as instruções do topo. Em cada caso, anote quantos dos 5 a pessoa chamaria em cada lista e qual lista usaria (A, B ou tanto faz). São 10 casos; se o tempo apertar, faça ao menos os 6 primeiros, na ordem. Não comente as listas e não diga como foram feitas. Ao final, pergunte: **o que mais pesou nas suas escolhas? Faltou alguma informação?**

E. Reação à tela (5 min): tela 2 do anexo

Nº	Pergunta
17	Mostre a tela sem explicar: "por que o primeiro da lista foi recomendado?" Anote se a pessoa entendeu sem ajuda.
18	De 1 a 5, o motivo está claro? Falta algum alerta?
19	Você aprovaria uma chamada com base nesta tela? O que precisaria para confiar?
20	Se a recomendação estiver errada e der problema, quem deve responder por isso?

6. Roteiro do plantonista (15 a 25 min)

Se o tempo apertar, faça só o bloco B.

A. Contexto (1 min)

Nº	Pergunta
1	Qual sua especialidade? Dá plantão em que tipo de serviço e hospital? Há quanto tempo: menos de 5 anos, de 5 a 10 ou mais de 10?

B. Como é hoje, em números (8 min)

Nº	Pergunta
2	Por semana, quantas ofertas de plantão você recebe? Por qual canal?
3	**De cada 10 ofertas, quantas você aceita?**
4	Quanto tempo costuma levar para responder?
5	Por que recusa? Ordene: agenda, distância, cansaço, valor, outro.
6	Até que distância aceita ir? Muda à noite?
7	Prefere noite, dia ou fim de semana? Em que condição aceita fora disso?
8	Nos últimos 3 meses, qual foi o máximo de horas seguidas que trabalhou? Costuma emendar plantões?
9	De cada 10 plantões que aceita, quantos acaba cancelando? Por quê?
10	Em quantos dias costuma receber? O atraso já fez você recusar um plantão?

C. Justiça e transparência (5 min)

Nº	Pergunta
11	De 1 a 5, as ofertas vão sempre para os mesmos médicos? (1: bem distribuídas; 5: sempre os mesmos)
12	Gostaria de saber por que recebeu uma oferta? E por que não recebeu?
13	Que informação **não** deveria ser usada para decidir quem recebe oferta?
14	Se achar que foi prejudicado, como gostaria de contestar?

D. Reação à tela (4 min): tela 4 do anexo

Nº	Pergunta
15	Mostre a tela sem explicar: "por que você recebeu esta oferta?" Anote se a pessoa entendeu sem ajuda.
16	"Como você contestaria?" Anote se achou o caminho sem ajuda.
17	De 1 a 5, você confia neste motivo?

7. Ficha de registro

Uma ficha por pessoa. Anote as respostas pelo número da pergunta, por exemplo: "5: típico 3 a 5, ruim 10".

Campo	Anote
Código	C__ ou P__
Consentimento	sim
Serviço e tipo de hospital, sem o nome	
Duração	
Respostas, por número	
Frases úteis, sem identificação	

Revisão às cegas, só para coordenadores:

Caso	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Lista A: chamaria quantos?										
Lista B: chamaria quantos?										
Usaria: A, B ou tanto faz										

Entregue as fichas ao Victor até 06/11, já sem nenhuma identificação.

8. O que cada resposta muda

Cada resposta entra na comparação com o que o simulador assume hoje, ao longo do ano simulado (2.448 vagas).

Pergunta do coordenador	O simulador assume	O que a resposta decide
3: vagas por mês	68 por hospital	O volume do caso de negócio
4: descobertas	4,8%	A linha de base da meta de cobertura
5: médicos chamados	3,09 ofertas por vaga	Qual linha da tabela da seção 1 vale
6: tempo até confirmar	Mediana de 83 min	A linha de base da meta de tempo
7: espera e tentativas	60 min para expirar, resposta média de 20 min, até 8 ofertas	Os tempos da simulação de fluxo
8: o que confere	Só CRM e especialidade	Se o filtro de regras é ganho real: ele responde por 72% do ganho simulado
9: quem chama primeiro	Sorteio que favorece quem mora perto e quem já está no hospital; 10% dos médicos recebem 27,7% das ofertas	A concentração de partida
10: faltas	Cerca de 96% comparecem	O peso do comparecimento
11: antecedência	74,5% publicadas com 24 h ou mais	O teto da meta de antecedência
12 a 15: horas e custos	Nada: o simulador não tem esses valores	O ROI
16: deu certo em 6 meses	Metas da Entrega 1	Os critérios de sucesso
Revisão às cegas	Nada: só pessoas medem isso	A meta de 60% de recomendações aceitas

Pergunta do plantonista	O simulador assume	O que a resposta decide
3: aceite	30,8% das ofertas	O nível da chance de aceite
4: tempo de resposta	Média de 20 min	Os tempos da simulação de fluxo
5: motivos de recusa	Agenda, distância, cansaço e outro; valor fica de fora	O que falta no modelo
6: distância	-0,09 por km na chance de aceite	O peso da distância
7: preferência	+0,7 quando o período coincide	O peso da preferência
8: horas seguidas	Limite de 24 h e descanso de 11 h	A regra de jornada
10: prazo de pagamento	Fora do ranking, por regra	Só contexto do problema; não entra no modelo
11 a 14: justiça	Sem premissa	As mitigações de concentração e a contestação

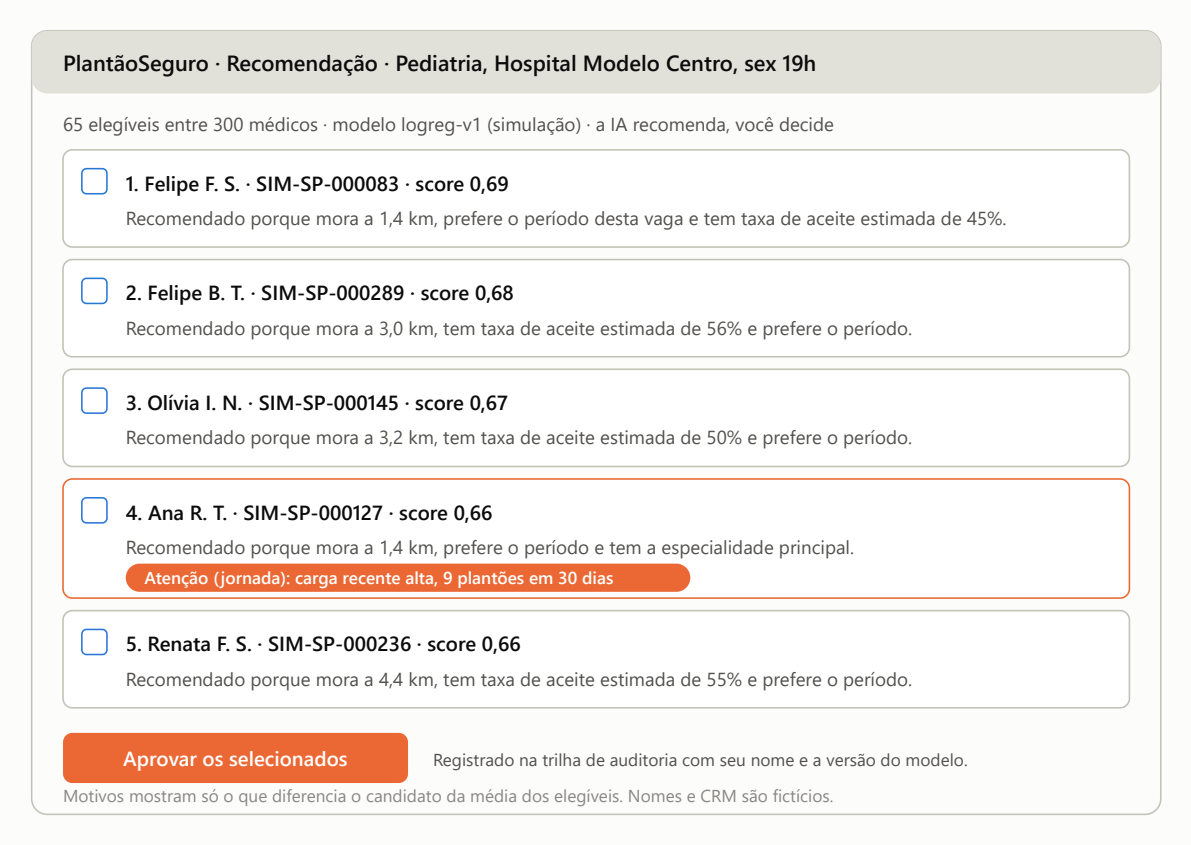
9. Depois das entrevistas

1. O grupo consolida as fichas em `docs/entrevistas/resultados.md`, só com agregados: quantas pessoas responderam, mínimo, mediana e máximo de cada número.
2. A revisão às cegas é calculada com o gabarito, depois que a última entrevista terminar.
3. Os números reais entram no teste de premissas e no documento da Etapa 3, com o tamanho da amostra sempre à vista.

Limite: são poucas pessoas, escolhidas por conveniência. O resultado mostra se as premissas são plausíveis e calibra a simulação; não prova o ganho. Quem prova é o piloto em paralelo descrito na Etapa 3.

Anexo: telas para mostrar

Protótipos em baixa fidelidade, com dados fictícios. Mostre uma de cada vez, só depois dos blocos de números.



Tela 2, para o coordenador: recomendação com motivo e alertas



Tela 4, para o plantonista: oferta com motivo e contestação